AXA · 데이터 2팀 · 진행 발표

# 메디대구 — 문제에서 사업 모델·화면 흐름까지

대구 등록 병원과 외국인 환자를 잇는 AI 의료관광 플랫폼 · 지금까지 정한 것

**페인포인트**
### 무엇이 막히나
근거 21건으로 후보 7개를 점수화 → **Top 3**

**밸류체인**
### 어디에 서나
5단계 네 층 맵, 병목 2·비용 2·기회 3 → **우선 기회 O1**

**BM 캔버스 v2**
### 누가 돈을 내나
12블록 캔버스 + 레드팀 3관점 21개 지적 → **v2**

**시나리오·플로우·IA**
### 어떻게 쓰나
As-Is → To-Be, 유저 스토리 7개, 예외 5개 → **MVP 범위**

주인공 (가정 페르소나)

**린** — 29세 타이베이 직장인, 3박 4일 대구 여행 중 피부 시술 1회

왜 대만인가

대구 대만 환자 2025년 **1,495명**, 전년보다 **+500.4%**

우리 위치

"등록 외국인환자 유치사업자" 가정으로 설계·시연 (등록 전)

출처: painpoint/ · valuechain/ · bm/ · spec/ · 대만 환자 수: 한국보건산업진흥원 2025 외국인환자 유치실적 통계 (bm_canvas 1절 확인값)

① 페인포인트

# 린이 막히는 곳은 "고르는 단계" — 정보가 비어 있다

VOC 대신 데이터·공식·통계 근거 21건 + 가정 3건 · 점수 = 빈도 × 강도 × 해결 가능성 (최대 125)

| 후보 | 여정 단계 | 빈도 | 강도 | 해결 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 진료시간 정보 없음 | ② 비교·결정 | 5 | 4 | 4 | **80** |
| Top 2 등록 병원 상세 부족 | ① 알아보기 | 5 | 3 | 5 | **75** |
| Top 3 피부·성형 가격 기준 없음 | ② 비교·결정 | 5 | 4 | 3 | **60** |
| 보류 병원 응답 대기 | ③ 상담 예약 | 3 | 5 | 3 | 45 |
| 보류 귀국 후 단절 | ⑤ 귀국 후 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 보류 동의서 이해 · 예약 확인서 | ③·④ | 해결 1 (병원·제도 몫) | | | 9 · 6 |

"병원 응답 대기"는 강도가 가장 높지만 환자 쪽 근거가 가정뿐 → 인터뷰 뒤 다시 봄

**26.1%** 진료시간 채움

대구 병원 월요일 진료시간 — 피부과 21.4%, 성형외과 14.1%. 플랫폼마다 표시 기준도 다름

**13 / 145** 상세 정보 있는 등록 병원

메디컬코리아 대구 등록 병원 중 통역 언어·진료시간 등 상세가 있는 곳

**0곳** 미용 시술 공공 가격

심평원 비급여에 의원급 미용 시술 가격 없음 → 플랫폼엔 병원이 정한 이벤트가 뿐

출처: painpoint/painpoint_def.md · evidence.csv (E01 심평원 API · E02 심평원 비급여 · E03 메디컬코리아 CSV) · 점수는 팀 판정

② 밸류체인 · 팀 검토 반영

# 우리는 탐색·비교 → 상담 예약에 서고, 정산에서 돈을 받는다

산업 7단계 중 메디대구가 닿는 줄기를 5단계로 잘라 활동·이해관계자·돈·데이터 네 층으로 그림

| | 1 병원 데이터·입점 | 2 탐색·비교 | 3 상담 예약·확정 | 4 방문·진료 | 5 사후관리·정산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메디대구 기능 | 데이터 파이프라인 (심평원·메디컬 코리아) · 병원 입점 | **AI 챗봇** · 가격 위치 표시 · 5개 언어 지도 | **상담 예약** · **병원 대시보드** (확정은 병원) | 미포함 — 진료·체류는 병원 몫 | 사후관리 채팅 · 방문 완료 → **월 정산** |
| 병목 · 비용 | B1 진료시간 빈칸 (채움 26.1%) | | B2 병원 응답 대기 [가정] | | C1 병원 중개비용 중첩 · C2 요금 항목 분리 — 구독료(대시보드)와 유치 수수료(진료비 대비 %)는 별개 |
| 기회 | ★ O1 공공데이터 + **출처·확인일** — 경쟁사 중 출처를 내세우는 곳 없음 | O3 수요 데이터 → 대시보드 | O2 AI 요약·답장 초안 (코디 승인 후 발송) | | |

### 먼저 간다 O1 공공데이터 + 출처·확인일

데이터가 이미 있고(대구 병원 4,242곳) 환자가 떠나는 비교 단계를 메움. 단 빈칸 채우기가 먼저

### 빠른 성과 O2 AI 답장 초안

B2 대기를 줄이는 병원 쪽 도구. AI 도구 일부는 이미 구현

### 풀어야 할 것 정산 근거

건당 수수료의 기준(진료비·완납)은 병원만 앎 → 병원 건별 입력 + 환자 확인으로 맞춤

출처: valuechain/step4_네층맵.md · step5_분석.md (5-4 쟁점, 5-5 우선순위) · 검토요청 · 병원 수: 심평원 API

③ AX BM 캔버스 v2

# 쓰는 사람은 환자, 돈 내는 사람은 등록 병원 (양면 시장)

Top 1 아이디어: 진료시간·가격 범위·등록 여부를 출처와 함께 자기 언어로 → 챗봇으로 상담 예약 → 병원은 AI 초안으로 빨리 답함

### 핵심 파트너

- 심평원·공공데이터포털, 메디컬코리아, 행안부(폐업), 한국은행 ECOS
- LLM 제공자 (Gemini → Nemotron 자동 전환)
- 입점 병원 · 대구시·특구 **[가정]**

### 핵심 활동

- 데이터 갱신 → 진료시간 빈칸·미용 가격 직접 수집
- 챗봇 → 요청서 → AI 초안 → 코디 승인
- 입점 영업 · 월 정산

### 핵심 자원

- 공공데이터 가공본 (대상 1,267곳, 칸마다 출처·확인일)
- 유치업자 등록 (자본금·보증보험 각 1억 원 이상)
- 5개 언어 UI · 챗봇 도구 11개

### 가치 제안

**환자** — 대구 병원의 진료시간·등록 여부와 **공공 자료가 있는 항목의 가격 범위**를 출처·확인일과 함께 내 언어로, 상담 예약까지 한곳에서

**병원** — 외국어 상담 요청을 AI가 요약·번역·답장 초안으로 정리 → 빨리 답하고, 유입·전환·응답 시간으로 성과 확인

AI 역할마다 사람 검토 지점: 발송은 코디 승인, 확정은 코디, 진단은 의료진

### 고객 관계

- 환자: 셀프 + AI 챗봇 (병원 정보는 가입 없이, 챗봇·예약은 로그인)
- 병원: 셀프 대시보드 + 입점 온보딩

### 채널

- 환자 웹 (5개 언어·지도·챗봇)
- 병원 대시보드
- 메디컬코리아·병원 홈페이지 링크

### 고객 세그먼트

**사용자** — 해외 거주 외국인 환자, 1순위 대만 미용·외래 단기 방문객 (국내 거주자는 정보 열람만)

**지불자** — 대구 등록 유치의료기관 145곳 중 **유치업체 계약 없이 외국어 문의를 직접 받는 피부·성형 의원**

확보 병원·LOI 지금 0곳

### 비용 구조

고정: 등록 요건(자본금·보증보험) · 인건비 · 호스팅 | 변동: LLM 사용량 · 정산·CS · 빈칸 수작업 | 리스크: 동의·국외 이전, 법률 검토, LLM 요금 변경

### 수익원

**주: 수수료** — 방문 완료·완납 1건 진료비의 % (월 정산) · 선택: **구독** (대시보드 이용료, 유치 수수료와 별개) · 보조: 일반 광고 배너 (병원 광고 아님)

출처: bm/bm_canvas.md v2 · bm/vpc.md · 등록 병원 145곳: 메디컬코리아 CSV · 등록 요건: 의료해외진출법 시행규칙 제4조

③ 수익모델 · 레드팀 검증

# 수수료가 주 수익원 — 다만 대만 미용만으로는 손익분기에 못 미친다

금액은 모두 가정값. 확인값은 법정 상한뿐 → 다음 시장 검증에서 숫자를 채움

## 수익모델 다섯 유형 대어 보기

| 유형 | 판단 |
|---|---|
| **수수료**<br>등록 병원 | 주 환자↔병원을 잇는 자리, 데모에서 돈이 오가는 장면이 가장 잘 보임 |
| 구독<br>등록 병원 | 선택 대시보드(AI 요약·번역·지표) 이용료 — 상한은 **유치 행위 대가**의 진료비 대비 비율이라 **다른 개념**. 환자 연결 대가는 구독에 넣지 않음 |
| 광고<br>일반 광고주 | 보조·나중 한국 화장품·관광 등, 병원 광고 아님 |
| 데이터 | 환자 질문·요청서는 건강정보 → 판매 불가에 가까움 |
| 라이선스 | 해당 없음 |

## 가격 가설 · 손익분기

유치업체 계약이 없는 등록 의원은 방문 완료 1건마다 진료비의 **5~10% (가정값)**를 낼 것이다 — 온 환자에 대해서만 내니까

법정 상한: 유치 수수료 ÷ 그 환자 총 진료비 ≤ 의원 30% · 병원 20% · 상급종합 15% (확인값) — 구독료와는 별개

**≈ 92건** / 월
손익분기 방문 완료 (계산값)

**≈ 9배**
예상 월 10건 대비

= 월 고정비 275만 원 ÷ 1건당 3만 원 (진료비 50만 원 × 7% − 5천 원), 모두 가정값

→ 구독 수익을 빼고 계산한 값. 국적 확장 (대구 외국인 환자 2025년 19,243명), 진료과 확장 필요

## 레드팀 3관점 · 지적 21개

고객 · 경쟁사 · 투자자 관점으로 v1을 공격

**16** 반영 **1** 일부 반영 **2** 추가 확인 **2** 보류·반박

- "가격 범위"를 **공공 자료가 있는 항목만**으로 좁힘
- 지불자를 "유치업체 계약 없는 의원"으로 좁힘 — 중개자를 하나 더 늘리지 않게
- "확정"은 코디가 확정한 뒤에만 표시
- LLM 요금·정책 변경을 리스크 비용에 추가

출처: bm/revenue_options.md · revenue_platform.md 3절 · redteam_log.md · redteam_diff.md · 유치 수수료 정의·상한: 통합 고시 제2조·제3조 (보건복지부고시 제2025-72호) · 19,243명: 진흥원 2025 통계

④ 서비스 시나리오 · 유저 플로우 · IA

# 린의 하루: 병원 찾기 → 상담 예약 "확정"까지 한 흐름

As-Is 장면마다 To-Be 화면 하나 · 필수 스토리 5개 = MVP 범위 · 화면 이름은 지금 웹사이트 메뉴 그대로

**메인**
대구 병원 지도
언어 선택

→

**병원 정보**
등록 병원 배지
US2

→

**병원 상세**
요일별 진료시간
+ 출처·확인일
US1

→

**가격 가이드**
대구 가격 범위
US3

→

**로그인 → 챗봇**
출처 붙은 답
US4

→

**상담/예약**
희망 날짜·언어·문의
→ "요청됨"

→

**병원 대시보드**
AI 요약·답장 초안
코디 승인 US5

→

**예약 관리**
상태: 확정

예외 5개 · E0 조건 맞는 병원 없음 → 필터 해제 · E1 진료시간 없음 → "병원에 묻기" · E2 공공 가격 없음 → 숫자 안 지어냄 · E3 챗봇 미답 → 직접 상담 요청 · E4 국내 거주 → 예약 막음

| As-Is (지금) | To-Be (메디대구) |
|---|---|
| 등록 병원 중 상세 정보 13곳, 통역 언어 모름 | 번체 지도에서 등록 병원만 보고 언어 배지 확인 |
| 진료시간이 비어 있고 플랫폼마다 다름 | 요일별 진료시간 + 출처·확인일, 없으면 "병원에 묻기" |
| 견적이 적정한지 비교 기준 없음 | 공공 자료가 있는 항목은 대구 범위 안 위치, 없으면 "자료 없음" |
| 병원 LINE·메일로 따로 묻고 기다림 | 챗봇에 묻고 그 자리에서 상담 예약 요청 |
| 코디가 문의를 번역해 상담지를 손으로 작성 | AI 요약·초안을 고쳐 승인 → 발송·확정 |

## IA — 홈에서 세 번 이내

메인 › 병원 정보 › 병원 상세 · 가격 가이드 · 챗봇 · 상담/예약 · 마이페이지 › 예약 관리. 병원 정보·상세·가격은 **가입 없이**, 챗봇·예약은 **로그인**

질문: 배지 라벨 "등록 유치의료기관" → "외국인 환자 등록 병원"?

## 다음

- **시장 검증** — 유치업체 요율, 코디 인터뷰, 지불자 병원 수
- **MVP** — US1~US5, "요청 → 답장 → 확정" 장면
- 나중: US6 사후관리 · US7 방문 완료·정산

출처: spec/scenario.md · userflow.md · ia.md · 페르소나 린은 가정 · 근거 번호 E01~E16은 painpoint/evidence.csv